

Treino e alimentação: princípios que valem para quase todo mundo

Um guia curto sobre o que a evidência sustenta — e sobre o que ela *não* sustenta. Sem dieta pronta, sem plano de treino, sem promessa.

Dr. José Victor Lisboa Cardoso Gomes · CRM-GO 38508
Clínica médica, medicina endocanabinoide e medicina esportiva · Goiânia-GO

Leia isto primeiro. Este material é educativo e trata de princípios gerais. Ele **não é uma prescrição**, não avalia o seu caso e não substitui consulta. Não existe plano de treino ou de alimentação que sirva para todo mundo — quem diz o contrário está vendendo alguma coisa. Se você tem doença crônica, usa medicação de uso contínuo, está grávida, tem menos de 18 anos ou sente dor ao se exercitar, converse com um médico antes de mudar rotina de treino ou de alimentação.

1. A ordem das coisas

A maior parte do resultado vem de poucas variáveis, e elas têm hierarquia. Gente que estaciona costuma estar otimizando a última linha da tabela e ignorando a primeira.

Peso	O que é
Muito alto	Constância ao longo de meses. Um treino perfeito que você faz três vezes perde para um treino mediano que você faz por um ano.
Alto	Sono suficiente e regular. É durante ele que a adaptação ao treino acontece.
Alto	Quantidade total de comida ao longo da semana, e quantidade de proteína.
Médio	Progressão de carga ou de volume — fazer hoje um pouco mais do que se fazia há dois meses.
Baixo	Escolha exata dos exercícios, ordem, horário das refeições.
Muito baixo	Suplementos, "janela anabólica", jejum em horário específico, detox.

Isto não quer dizer que a última linha seja inútil. Quer dizer que ela só aparece quando as de cima já estão resolvidas — e quase nunca estão.

2. Treino

Quanto

As recomendações internacionais de atividade física para adultos convergem em torno de **150 a 300 minutos por semana** de atividade aeróbica moderada — ou metade disso em intensidade vigorosa — mais **dois dias de trabalho de força** para os grandes grupos musculares.

Se você está em zero, o salto que mais muda desfecho não é chegar aos 150. É **sair do zero**. A curva de benefício é mais íngreme no começo: quem faz 40 minutos por semana já está num lugar bem diferente de quem faz nada.

Força não é opcional depois dos 30

A perda de massa e de força muscular com a idade começa antes do que se imagina e acelera depois dos 60. Ela é um dos determinantes de autonomia na velhice — e o trabalho de força é a única intervenção que a enfrenta diretamente. Não é estética; é o que decide se aos 80 anos você levanta sozinho de uma cadeira.

Progressão

O corpo se adapta ao que é exigido dele. Se a exigência não muda, a adaptação para. Progredir pode ser mais carga, mais repetições, mais séries, menos descanso ou melhor execução — não precisa ser sempre carga, e não precisa ser toda semana.

Dor

Desconforto muscular difuso que aparece um ou dois dias depois e melhora sozinho é esperado. **Dor localizada, em fisgada, que aparece durante o movimento e piora ao repetir, não é.** Essa segunda merece avaliação, e "treinar através dela" costuma transformar um problema de semanas em um problema de meses.

Pare o exercício e procure atendimento se aparecer: dor no peito, falta de ar desproporcional ao esforço, tontura, desmaio ou quase desmaio, palpitação que não passa, dor de cabeça súbita e intensa. Em emergência, procure atendimento imediato ou ligue **192 (SAMU)**. Isso vale mesmo que você seja jovem e treinado.

3. Alimentação

Proteína

É o ponto em que mais gente erra para baixo. As faixas usadas em pessoas ativas costumam ficar entre **1,2 e 2,0 g por quilo de peso por dia**, distribuídas ao longo do dia. Para a maioria, o problema não é a distribuição perfeita — é que o total do dia fica muito abaixo disso.

Quem tem doença renal precisa de orientação individual sobre proteína. Esta faixa não se aplica automaticamente.

O resto do prato

- **Comida de verdade na maior parte do tempo.** Alimentos minimamente processados — o que se reconhece como planta ou animal — em vez de ultraprocessados.
- **Fibras.** Frutas, verduras, legumes, grãos integrais e feijões. Quase toda a população brasileira come menos do que o recomendado.
- **Água.** Sede é um bom guia para a maioria das pessoas saudáveis. Urina muito escura ao longo do dia sugere que está faltando.
- **Álcool.** Não existe dose que melhore desempenho ou saúde. Se você bebe, quanto menos, melhor — e isso é o que a evidência recente sustenta, não moralismo.

O que não precisa

Detox, chá que queima gordura, suplemento que "acelera o metabolismo", cortar glúten ou lactose sem diagnóstico, comer de três em três horas obrigatoriamente. Nada disso tem sustentação, e o custo não é só o dinheiro: é a atenção gasta com o que não muda resultado enquanto sono e constância seguem em falta.

Sobre suplementos. Alguns têm evidência razoável em contextos específicos — creatina para força, cafeína para desempenho, vitamina D quando há deficiência comprovada em exame. Ainda assim: nenhum deles compensa dormir mal, e o uso de qualquer um em quem tem doença crônica ou usa medicação contínua deve ser conversado com médico. Suplemento é complemento — o nome já diz.

4. Sono

Sete a nove horas para a maioria dos adultos. Não é conselho de rodapé: dormir mal derruba desempenho, aumenta fome, atrapalha a recuperação e piora o humor — os quatro ao mesmo tempo.

O que costuma funcionar: horário de dormir e de acordar parecidos todos os dias, inclusive no fim de semana; quarto escuro e fresco; cafeína só até o meio da tarde; tela longe da cama.

Ronco alto com pausas na respiração, ou sono não reparador apesar de horas suficientes, merecem investigação. Apneia do sono é comum, subdiagnosticada e tratável.

5. Quando procurar um médico antes de começar

- Doença cardiovascular conhecida, ou fatores de risco não avaliados
- Diabetes, hipertensão ou doença renal
- Dor articular ou muscular que já limita movimento
- Cirurgia ou lesão recente
- Uso contínuo de medicação
- Gravidez
- Mais de 40 anos e nenhuma avaliação nos últimos anos
- Qualquer sintoma durante esforço — nesse caso, antes de continuar

6. Um resumo honesto

Se você fizer só três coisas: **durma o suficiente, coma proteína e comida de verdade, e treine com constância, incluindo força**. O resto é ajuste fino, e ajuste fino só rende quando o principal já está em pé.

E o mais importante: o que está escrito aqui vale para "quase todo mundo". Você não é quase todo mundo — é uma pessoa, com histórico, exames, sintomas e rotina próprios. É disso que uma consulta trata.

Este material é educativo. Não estabelece relação médico-paciente, não avalia caso individual e não substitui consulta. Não há promessa de resultado. Conteúdo de responsabilidade de Dr. José Victor Lisboa Cardoso Gomes, CRM-GO 38508. Em emergência: 192 (SAMU). Em sofrimento emocional: 188 (CVV), 24 horas, gratuito.